

Sistema Utera

MATRIZ CLÍNICA — ETAPA 1

Rastreamento Hormonal Funcional — Método ÚTERA

Premissa central

O sistema não deve interpretar sintomas isolados.
Ele deve reconhecer padrões fisiológicos e comportamentais.

A lógica clínica base será:

4 ou mais sinais dentro de um eixo = possível desequilíbrio funcional daquele eixo.

Os sintomas devem ser interpretados:

- dentro da fase do ciclo
 - em associação com outros sinais
 - considerando padrão recorrente
 - considerando progressão ao longo dos meses
-

1. EIXO ESTROGÊNICO

Dominância estrogênica / metabolização estrogênica comprometida

Sintomas-chave

- fluxo menstrual intenso
- coágulos
- cólica forte
- dor mamária
- edema/retenção
- enxaqueca cíclica
- irritabilidade pré-menstrual
- acne cíclica
- intestino preso principalmente na fase lútea
- sensação de inchaço corporal

Interpretação clínica

Pode sugerir:

- dominância estrogênica relativa
- baixa oposição da progesterona
- dificuldade de metabolização hepática
- estroboloma alterado
- maior recirculação intestinal de estrogênio
- maior carga inflamatória

Critério inicial de alerta

≥ 4 sinais associados

2. EIXO PROGESTERONA

Fase lútea / baixa progesterona funcional

Sintomas-chave

- insônia antes da menstruação
- irritabilidade
- ansiedade
- compulsão por doces
- piora importante do humor na fase lútea
- spotting/escape antes da menstruação
- baixa energia pré-menstrual
- maior sensibilidade emocional
- pior tolerância ao estresse
- sono leve ou fragmentado na fase lútea

Interpretação clínica

Pode sugerir:

- baixa progesterona funcional
- fase lútea insuficiente
- ovulação fraca
- pior modulação GABAérgica
- maior impacto neuroquímico da fase lútea

Critério inicial de alerta

≥ 4 sinais associados

3. EIXO GLICÊMICO

Resistência à insulina / glicemia instável

Sintomas-chave

- irritabilidade quando fica muito tempo sem comer
- tremores ou ansiedade em jejum
- desejo intenso por doces
- compulsão no final do dia
- sonolência após refeições
- queda de energia entre refeições
- calorões associados a jejum
- piora do rendimento no treino
- fome intensa ao acordar de madrugada
- sensação de “corpo inflamado” após excesso de carboidratos

Interpretação clínica

Pode sugerir:

- glicemia instável
- resistência à insulina
- hipoglicemia reativa
- pior flexibilidade metabólica
- maior ativação de cortisol compensatório

Critério inicial de alerta

≥ 4 sinais associados

4. EIXO ADRENAL

Cortisol / estresse / recuperação

Sintomas-chave

- acordar cansada
- insônia
- despertares noturnos
- agitação com cansaço
- ansiedade
- irritabilidade
- compulsão noturna
- baixa recuperação pós-treino
- dores corporais frequentes
- energia instável ao longo do dia
- sensação de “alerta constante”

Interpretação clínica

Pode sugerir:

- desregulação do cortisol
- hiperativação do eixo HPA
- fadiga de recuperação
- sobrecarga fisiológica
- baixa tolerância ao estresse

Critério inicial de alerta

≥ 4 sinais associados

5. EIXO INTESTINAL / ESTROBOLOMA

Intestino e metabolismo hormonal

Sintomas-chave

- constipação
- intestino solto
- alternância intestinal
- gases
- distensão abdominal
- acne persistente
- cólica menstrual
- fluxo intenso
- dor mamária
- piora hormonal quando intestino trava
- sensação de digestão lenta

Interpretação clínica

Pode sugerir:

- disbiose intestinal
- estroboloma alterado
- maior recirculação estrogênica
- inflamação intestinal
- pior excreção hormonal
- comprometimento da barreira intestinal

Critério inicial de alerta

≥ 4 sinais associados

6. EIXO INFLAMATÓRIO

Inflamação sistêmica funcional

Sintomas-chave

- cólica intensa
- enxaqueca
- dor articular
- edema
- acne inflamatória
- fluxo intenso
- coágulos
- fadiga importante
- pior recuperação muscular
- sensação de corpo dolorido

Interpretação clínica

Pode sugerir:

- maior atividade inflamatória sistêmica
- pior resposta antioxidante
- maior carga inflamatória hormonal
- inflamação intestinal associada

Critério inicial de alerta

≥ 4 sinais associados

7. EIXO ANDROGÊNICO

Hiperandrogenismo funcional

Sintomas-chave

- acne mandibular
- oleosidade excessiva
- queda de cabelo
- irregularidade menstrual
- ciclos anovulatórios
- dificuldade de perceber ovulação
- redução de muco cervical fértil
- aumento de pelos
- piora de pele na ovulação ou fase lútea
- compulsão associada à resistência insulínica

Interpretação clínica

Pode sugerir:

- hiperandrogenismo funcional
- resistência à insulina associada
- sensibilidade tecidual androgênica
- padrão compatível com SOP
- maior atividade de 5-alfa-redutase

Critério inicial de alerta

≥ 3–4 sinais associados

8. EIXO PERIMENOPAUSA / TRANSIÇÃO HORMONAL

Sintomas-chave

- ciclos irregulares
- ciclos espaçando progressivamente
- amenorreia temporária

- fluxo imprevisível
- aumento ou redução importante do fluxo
- calorões
- suor noturno
- insônia
- irritabilidade
- dor articular
- fadiga
- piora de enxaqueca
- oscilação emocional
- mudança metabólica inexplicável

Interpretação clínica

Pode sugerir:

- transição menopausal
- oscilação estrogênica importante
- redução progressiva da progesterona
- maior instabilidade neuroendócrina
- alteração da estabilidade glicêmica e cortisol

Progressão clínica esperada no sistema

Perimenopausa inicial

- ciclos variando ≥ 7 dias
- início de irregularidade
- sintomas oscilatórios leves

Perimenopausa intermediária

- ciclos começando a espaçar
- períodos de 45–60 dias sem menstruar
- sintomas vasomotores mais presentes

Perimenopausa tardia

- meses sem menstruar
- retorno ocasional do ciclo
- grande instabilidade hormonal
- piora importante de sono, humor e calorões

Menopausa provável

- ≥ 12 meses sem menstruar

Critério inicial de alerta

≥ 4 sinais associados + mudança progressiva do padrão menstrual

PRINCÍPIOS DO SISTEMA

- O sistema deve interpretar padrões, não sintomas isolados
- Os sintomas devem ser analisados dentro da fase do ciclo
- A recorrência é mais importante do que episódios únicos
- Os eixos podem coexistir simultaneamente
- O sistema deve gerar consciência e responsabilização, não medo
- O objetivo é traduzir fisiologia feminina em linguagem compreensível e clínica